

Patienteninformation Besenreiser

Was sind Besenreiser?

Besenreiser sind die kleinste Form von Krampfadern, welche sich in der Haut befinden und deshalb gut sichtbar sind. In den allermeisten Fällen sind Besenreiser ein kosmetisches Problem, gefahrlos und nur in seltenen Fällen verursachen sie Schmerzen. Besenreiser treten über Jahre oder innerhalb Monaten in Erscheinung, wie zum Beispiel während der Pubertät, der Schwangerschaft oder mit zunehmendem Alter.

Ursachen und Häufigkeit der Besenreiser

Praktisch jede zweite bis dritte Frau leidet unter kosmetisch störenden Besenreisern. Die Hauptursache ist praktisch immer genetisch bedingt. Bei über 90 % der betroffenen Frauen hatte bereits die Mutter, der Vater oder die Grosseltern kleinere oder grössere Krampfadern oder eben die kleinste Form von Krampfadern, die sogenannten Besenreiser. Selbst Top-Models mit schlanken, sportlichen Beinen, Normalgewicht, gesunder Ernährung, Verzicht auf Rauchen und Alkohol, bleiben von kosmetisch störenden Besenreisern nicht verschont, wenn die Veranlagung besteht. Besenreiser entstehen häufig als Folge von grösseren Füllungsquellen (Krampfadern). Deshalb muss vor jeder ersten Verödungstherapie von kosmetisch störenden Besenreisern mittels Farbultraschall ausgeschlossen werden, dass keine grösseren oberflächlichen- oder tiefen Krampfadern als Füllungsquelle vorhanden sind. Ansonsten treten rasch nach der Verödungstherapie oder der Laserbehandlung erneute kleine Äderchen auf.

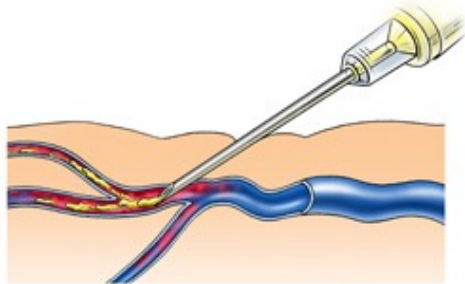
Grundabklärung der Beinvenen vor jeder Therapie

Vor dem Beginn jeder Therapie von kleinen als auch grossen Krampfadern ist eine phlebologische Grunduntersuchung der oberflächlichen- und tiefen Beinvenen notwendig. Diese Vorabklärung besteht aus einer Befragung des Patienten (=Anamnese) Abklärung von Beschwerden, die Erfassung bereits durchgeführten Therapien, einer nicht-invasiven Farbultraschall Untersuchung, FKDS) und einer nicht-invasiven Messung des venösen Gesamtabstroms in Ruhe und Aktivität (Licht Reflexions Rheographie, LRR).

Zeigt die phlebologisch apparative Grunduntersuchung der Beinvenen keine grösseren Füllungsquellen als Ursache der kosmetisch störenden Hautäderchen, können diese lokal angegangen werden. Etablierte Methoden sind heute die Verödungstherapie (Sklerotherapie), die Schaumverödung (Foam Therapie) mit Aethoxysklerol, die „Bio-Verödung“ mit Kochsalzlösung, die lokale Phlebectomie (Häkelmethode), die Radiowellentherapie und die YAG-Lasertherapie.

Sind grössere Füllungsquellen als Ursache der kleinen Krampfadern auffindbar, müssen diese gezielt ausgeschaltet werden. Die aktuell gängigsten Therapiemethoden sind die minimal invasiv chirurgische Methode (Crossectomie, Venenstripping) und die moderne endovenöse Kathetertherapie (Laser, Radiofrequenz, Mechanochemische Ablation, Kleber). Werden die Füllungsquellen nicht therapiert, führen auch modernste Therapieanwendungen zu kosmetisch schlechten Resultaten.

Besenreiser entfernen – verschiedene Techniken



1. Verödungstherapie

Die allermeisten Besenreiser werden heute mit der Verödungstherapie (Sklerosierungstherapie) behandelt. Dabei wird eine spezielle Injektionslösung in die Vene gespritzt. Diese löst in der Innenwand der kleinen Krampfader eine Entzündung aus. Nach der Behandlung werden die entzündeten Venenwände mit einem Druckverband (Kompression) verklebt. Je konsequenter und enger dieser in den ersten 6-12 Stunden getragen wird, desto besser sind die Resultate.

Schaumverödung der Besenreiser

Diese oft als „neu“ propagierte Methode ist unter Spezialisten seit 1946 bekannt. In der Tat ist die „Schaumverödung“ nichts anderes als die langjährig bekannte und bewährte Verödungstherapie. Der einzige Unterschied ist, dass mit der Injektionslösung und Luft ein Schaum (feinste Luftblasen) erzeugt wird. Durch die Luftblasen werden die feinen Besenreiser blutleer gespritzt und das Injektionsmittel kann an den blutleeren Gefäßwänden eine stärkere Entzündung auslösen.

Verlauf der Verödungstherapie

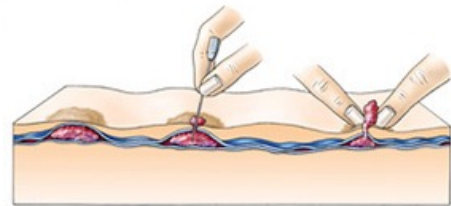
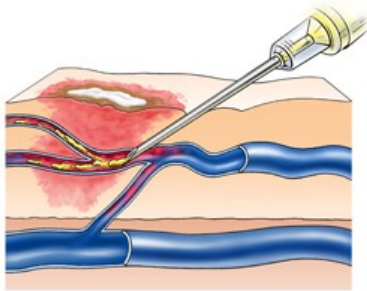
Bei korrekter Technik sind Schmerzen bei der Verödungstherapie minimal. Spürbar bleibt ein kleiner Stich der feinen Nadel, gefolgt von einem kurzen Brennen im Bereich der Besenreiser, welche vom Verödungsmittel durchflossen werden. Gelegentlich müssen grössere „Besenreiser- Nester“ mehrmals verödet werden, um ein gutes Resultat zu erzielen.

Komplikationen bei Verödungstherapie von Besenreisern

Eine Komplikation der Verödungstherapie (Sklerosierung) sind Begleitentzündungen vom Gewebe und können zu Hautnekrosen und narbiger Abheilung führen. Diese Komplikation ist bei niedriger Konzentration des Verödungsmittels und in geübten Händen in ca. einem Promille zu erwarten. Besonders gross ist diese Gefahr bei zu hochkonzentriertem Verödungsmittel, bei einer Verödungsmittel-Unverträglichkeit und einer anatomischen Variante.

Eine weitere Komplikation der Verödungstherapie (Sklerosierung, Schaumverödung) sind sogenannte „Matting“, die noch kleinere Form von Besenreisern. Matting treten- meist aufgrund der Anatomischen Situation – nach einer Verödungstherapie hauptsächlich im Bereich des seitlichen Oberschenkels auf. Durch die Verödungstherapie werden die grösseren Nährvenen der jeweiligen Besenreiser mit dem Verödungsmittel verschlossen.

Dadurch werden feinste Äderchen gestaut und treten in Form von Matting's meist radiär auf. Diese können mit weiteren Verödungstherapien angegangen werden, deren Behandlung erfordert aber oft viel Geduld sowohl vom Arzt als auch dem Patienten. Oft verschwinden Matting's aber auch ohne weitere Therapie während Monaten.



Hautnekrosen und narbige Abheilung

Matting's

braune Verfärbungen

Nach Verödungstherapie/ Schaumverödung können sich alte thrombosierte Blutreste in nicht verklebten Venenabschnitten bilden. Diese sollten, sofern sie nicht spontan innerhalb von 3-4 Wochen verschwinden, mit einer feinen Nadel oberflächlich punktiert und ausgedrückt werden. Bleiben diese alten Blutreste unter der Haut liegen, werden sie über Monate als braune Verfärbungen sichtbar bleiben und hellen erst mit den Monaten langsam auf. Zudem bilden sich verfärbte Hautstellen durch das Tragen von Kompressionsstrümpfen rascher zurück.

Duschen, Sport, Arbeiten usw. ist nach der Verödung sofort erlaubt und auch empfehlenswert. Nur Sonnenlicht sollte auf den verödeten Stellen vermieden werden, andernfalls hält die Braunverfärbung viel länger an.

Grundsätzlich gilt bei der Verödung, dass Patienten geduldig sein müssen. Das gute Resultat ist oft erst nach ca. 3- 6 Monaten sichtbar, dann nämlich, wenn die Braunverfärbungen oder allfällige Matting's abgeblasst sind. Die Verödung möglichst früh im Herbst zu beginnen ist deshalb von Vorteil.

2. Lasertherapie von Besenreisern und retikulären Krampfadern

KLF- Methode (kombinierte Laser – Foam Therapie)

Eine 100 Prozent Erfolg versprechende Therapie zur Entfernung von kleinen Krampfadern (Besenreiser, retikuläre Krampfadern) gewährt bis heute keine Methode. In der Kombination verschiedener etablierter Therapiemethoden kann jedoch in den häufigsten Fällen eine deutliche Verbesserung der kosmetisch störenden, kleinen Krampfadern erreicht werden. Entgegen der landläufigen Meinung, dass kleine Krampfadern rasch und zuverlässig allein mit einer Lasertherapie oder Radiowellentherapie verschwinden, ist in den meisten Fällen eine falsche Vorstellung. Oft führt erst die Kombinationstherapie verschiedener Methoden zu guten Resultaten (KLF- Methode)

KLF-Methode

In der Regel wird in einem ersten Schritt ein feinblasiger Schaum (Foam) in die kleinen Krampfäderchen gespritzt. Der Schaum dehnt sich flächenförmig bis in die kleinsten Verästelungen aus und bewirkt eine Entzündung der Venenwände. Ein unmittelbar an die Verödung angelegter straffer elastischer Kompressionsverband führt zu einer Verklebung der entzündeten Venen Innenwände. Der Kompressionsverband sollte wenn möglich konsequent während mindestens 12 Stunden getragen werden. Dies bewirkt eine verbesserte Verklebung der Venenwände und minimiert die Braunverfärbungen.

Sehr feine Äderchen (Matting), welche mit der Schaumverödung nicht punktiert werden können, werden gleichzeitig oder zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Hochleistungs-Laser (YAG- Laser Technologie) angegangen. Mit dieser Kombination werden sowohl grössere als auch die kleinste Gefässe therapiert.



Abheilungszeit

Sowohl die mit dem Laser- als auch mit der Schaumverödung behandelten Hautareale heilen in der Regel innerhalb von 4- 6 Wochen ab. Anfänglich sind die Hautareale leicht gerötet, schmerzhaft und kleine oberflächliche Hautblutungen vorhanden. Diese verschwinden in der Regel nach 7-10 Tagen oder wandeln sich in braunverfärbte Areale oder Striche um. In seltenen Fällen bleiben diese Braunverfärbungen längere Zeit bestehen. Braunverfärbte Hautareale müssen konsequent vor Sonnenlicht mit Abdeckung oder Cremen- mit hohem Sonnenschutzfaktor- geschützt werden. Andernfalls können Pigmentverschiebungen während vieler Monate bis Jahre bestehen bleiben.

Sticheln (Needling) von dunklen Hautarealen nach der Schaumverödung und der Lasertherapie

Sowohl die Schaumverödung als auch die Lasertherapie von grösseren Krampfäderchen (retikuläre Varikose) führen in den meisten Fällen zu vorübergehend dunklen, strichartigen Hautveränderungen. Diese sind Folge nicht verklebter Venenabschnitte mit altem Blut (kleinen Thrombosen) und müssen spätestens nach 10 – 14 Tagen mit feinen Nadeln angestochen (Needling) und ausgedrückt werden. Ansonsten sind aufgrund der Eisen haltigen Blutkoagula Verfärbungen der Haut während Monaten und Jahren sichtbar.

Sind Kompressionsstrümpfe und Salben nach der Behandlung notwendig?

Das Tragen von einem medizinischen Kompressionsstrumpf (Klasse 2 oder 3), das Auftragen von Hautsalben und Sonnenschutzcremes unterstützen den schnelleren Rückgang von Blutergüssen und Braunverfärbungen.

Treten neue Besenreiser nach einer Laser- oder Schaumverödungstherapie auf, wie oft muss gelasert werden?

Die Neigung für die Bildung von grösseren als auch kleinen Krampfaden/ Äderchen ist genetisch bedingt (vererbt). Deshalb werden mit grosser Wahrscheinlichkeit auch nach der Laser-/ Schaumverödungstherapie (Foam) neue Besenreiser an anderen Hautregionen bilden. Mit der Therapie werden lediglich die momentan kosmetisch störenden Äderchen therapiert.

Die Anzahl notwendiger Therapiesitzungen kann nur abgeschätzt werden. Die Ergebnisse sind individuell sehr verschieden, ebenso der kosmetische Anspruch. In allen Fällen gilt: Haben Sie Geduld.